乳房疾病 ★★★（0~3题）

乳腺癌

- 雌激素暴露时间延长如月经早、绝经晚、晚育不育、肥胖（2015、2020）
- 分期（2017）
  - T（长径）—— T1 ≤ 2，T2，T3 > 5，T4 侵犯皮肤 / 胸壁 / 炎性乳癌“25 肤鼻炎”
  - N —— N0 无
N1 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大可推动
N2 同侧腋窝淋巴结无痛性肿大推不动（融合粘连）
N3 同侧胸骨旁或锁骨上淋巴结无痛性肿大
  - M —— M0 无远处转移，M1 有远处转移（IV期）
  - Ⅱ期：T2-3N0、T0-2N1
- 分子亚型 —— ER、PR、HER2、Ki-67
- 表现（2012、2014）
  - 最早最常见：肿块 —— 外上象限多见（2015），多单发、无痛、质硬、分界不清、不易推动
  - 血性溢液、乳头凹陷（2008、2010、2012、2016、2019）
  - 皮肤 —— 凹陷（酒窝征）：侵犯 Cooper/ 乳房悬韧带
水肿（橘皮样变）：阻塞淋巴管
卫星结节、粘连、恶臭溃疡、红肿等炎症样（炎性乳癌）、糜烂等湿疹样（Paget 病）
  - 淋巴转移最早最常见；早期可有血道转移至骨、肺、肝等“全身性疾病”（2021）
  - 炎性乳癌预后最差：可无明显肿块，主要是化疗放疗（2007）
- 检查
  - 筛查：钼靶 X 线（毛刺、细小密集的泥沙样钙化）+ 超声（可观察血供）
  - 金标准：活检（不宜切取部分活检）
  - CA153“五年高考三年模拟忍辱负重”
  - 抑癌基因 BRCA 缺陷：可考虑预防性乳房全切术
  - 放射性核素骨扫描 ECT：显示乳腺癌骨转移灶（乳腺癌经椎旁静脉系统转移至脊椎骨尤其椎弓根可致腰背痛）
- 手术为主的综合治疗
  - 手术（2026）
    - 全乳房切除术（不清扫淋巴结）→原位癌、微小癌、年老不宜作根治术者
    - 保乳乳腺癌切除术→ Ⅰ、Ⅱ期：切肿块 + 周围 1~2cm 组织，术后必须放疗
    - 腋淋巴结阳性→清扫，腋淋巴结阴性→前哨淋巴结活检→阳性清扫、阴性不清扫（2014）
  - 几乎要化疗（2009）
含紫杉醇的 TC/ETC“抬杠” —— 浸润性癌伴腋淋巴结阳性
腋淋巴结阴性但有高危复发因素（> 2cm、分化差、ER/PR-、HER2+）“2 分之 2=1”
  - ER+ →内分泌治疗 —— 雌激素受体拮抗剂三苯氧胺 / 他莫昔芬（绝经后用芳香化酶抑制剂阿那曲唑 / 依西美坦）“吃他三、阿姨”（2026）
  - HER2+ →靶向治疗 —— 曲妥珠单抗 / 赫赛汀“去喝”
- 鉴别
  - 乳腺纤维腺瘤（2025）—— 肿块多单发、无痛、质硬似像皮球
但肿块增长缓慢、边界清楚、易推动，淋巴结无肿大，多 20~25 岁
切除肿瘤 + 常规病检
  - 乳管内乳头状瘤（2024）—— 最易血性溢液（若乳管阻塞呈棕褐色），常不能触及肿块
6%~8% 恶变率→切除病变乳管 + 常规病检